جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : شروق محمد نادر عبدالعزيز
المحافظة : الشرقيه **الحي / المدينة :** ابوحماد **العنوان :** الشرقيه
رقم البطاقة : 28310271301485 **رقم التليفون :** 01125474120 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 27-10-1983 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: شروق محمد نادر عبدالعزيز
National ID: 28310271301485

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



شروق
محمد نادر عبدالعزيز شحاته
ش الزهراء حى ابومغازى
مركز أبوحماد - الشرقية

٢٨٣١٠٢٧١٣٠١٤٨٥

JP1737376

DMS 1470

٤٠٤٣ / C-C٦



٢٨٣١٠٢٧١٣٠١٤٨٥ ٢٠٢٢/١٠

محام حر

انثى مسلمة متزوجة

أيمن محمد حسن رفاعى

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/١٠/٠٩



National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

PATIENT NAME: SHOROK MOHAMED ABD EL AZIZ SHEHATA **GENDER:** Female **DATE :** 30-Sep-2026 03:11 PM	**PATIENT ID:** 20226033042 **AGE:** 42 y **ORDER:** Z530196,Z530265

CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY

INDICATION:

- **Right breast UOQ pathologically proven micropapillary carcinoma with ER- PR positive HER 2 amplified**
- **Right & left axillary level I indeterminate LNs , FNAC no malignancy .**
- Left breast normal study (BIRADS 1).

TECHNIQUE:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography CC and MLO views
- IV low osmolar non-ionic contrast medium infusion 100 ml

REPORT:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography showed bilateral symmetrical back ground parenchymal enhancement.

Right breast:

- UOQ and UIQ showing moderate heterogenous non mass enhancement measured 86X31X45mm, being 14 mm from the nipple.
- Corresponding US revealed altered non parenchyma with no pathological vascularity detected upon Color Doppler application ? adenotic /neoplastic .
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.

Left breast:

- UIQ showing minimal heterogenous non mass enhancement measured 13x37x50mm, being 17 mm from the nipple with no Ultrasound correlation ?adenotic /neoplastic .
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.

OPINION:

-Right breast non mass.with suspicious enhancement (BIRADS 6).
-Left breast UIQ pathological non mass enhancement yet regarding the PET CT results , adenosis is to be considered (BIRADS 3)

www.Baheya.org
16602
مركز بهية الهرم
4 شارع علوية أول شارع الهرم بجوار داري ، الجيزة
مستشفى بهية الشيخ زايد
٤ الحي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Patient Name:	شروق محمد نصر عبدالعزيز		
MRN:	10110326015838	Location:	External Clinic
D.O.B:	27/10/1983	Sex:	Female
IC No.:	28310271301485		

Surgical Pathology-Amended Diagnosis

Biopsy

Specimen Id	2609231533	**Collection Date**	23/09/2026 01:30 PM
Accession No	P-26-12306	**Received Date**	23/09/2026 01:30 PM
Sample Type	TISSUE	**Doctor**	

CLINICAL HISTORY

Right breast lesion, Tru-cut biopsy. sent for revision

GROSS DESCRIPTION

One referred paraffin block, One referred H & E stained slide & Three referred immunostained slides coded 203997

MICROSCOPIC DESCRIPTION

- Histologic type : Invasive micropapillary carcinoma
- Histologic grade : Grade II (Intermediate).
- Ductal carcinoma in situ (DCIS) : Identified
- Nuclear grade : Grade II (Intermediate)
- Necrosis : Not identified.
- Lymphovascular emboli : Identified.
- Perineural invasion : Not identified.
- Special studies (including hormone receptor) :

ER is positive, showing strong positive reaction for 90% of tumor cells, score 8/8.
PR is positive, showing strong positive reaction for 60% of tumor cells, score 7/8.
Her2/neu is equivocal. Score 2+
SISH is amplified

DIAGNOSIS

Right breast lesion, Tru-cut biopsy, Revised block & slides: Invasive micropapillary carcinoma. Grade 2

Category

Malignant primary site (single tumor)

Assistant Pathologist.
Dr. Asmaa Abdelrahman

Registrar:

Signed by:
Dr. Iman G. Farahat, MD (Professor)

Report issued electronically endorsed by Dr. Asmaa Abdelrahman

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

MRN:	20226033042		
Patient Name:	SHOROK MOHAMED ABD EL AZIZ SHEHATA	D.O.B:	27/10/1983
IC No.:	28310271301485	Sex:	Female
Location:	External Clinic		

IMMUNOPATHOLOGY

Hormone receptors

Specimen Id	992609030092	**Collection Date**	03/09/2026 09:18 AM
Accession No	Z-IMM-26-203328	**Received Date**	03/09/2026 09:19 AM
Sample Type	Paraffin Block	**Doctor**	Reem Taha Hassan Mohamed Al-Sayed

Immunohistochemical Report

pathology number
203997-26

Clinical Data
Rt. breast cancer.

Gross Picture :
Referred block submitted for ER/PR immunostaining.

System Used :
Ventana BenchMark ULTRA autostainer.

Antibody:
Ventana anti-PR[1E2] Rabbit monoclonal antibody, Ventana anti-ER[SP1] Rabbit monoclonal antibody.

Scoring system :
According to the ASCO/CAP guideline update, 2019 : Samples with 1% to 100% of tumor nuclei positive for ER or progesterone receptor (PgR) are interpreted as positive. If ER (not PgR), 1% to 10% of tumor cell nuclei are immunoreactive, the sample are reported as ER Low Positive. A sample is considered negative for ER or PgR if < 1% or 0% of tumor cell nuclei are immunoreactive.

Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, <1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%–100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

Comment:
- There are much more limited data on the 2% to 3% of cancers that are low ER expressers (most often defined as 1%-10% ER-positive cells by IHC) and their potential benefit from endocrine therapy.

www.Baheya.org 16602
مركز بهية الهرم
4 شارع علوية أول شارع الهرم بجوار داري , الجيزة
مستشفى بهية الشيخ زايد
٤٠ الحي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Diagnosis #1
Rt. breast Cancer:
Her-2 gene: Amplified (Her2/Chr17 =2.8 and average Her2 copy number is 4.5.

Site 2

Signature
SAFY HOSNY AHMED

Reported and electronically endorsed by
Safi Hosny Ahmed Teilab

Pathology lab director:
Dr. Hazem Abdelazim, MD, IFCAP

www.Baheya.org
16602
مركز بهية الهرم
٤ شارع علوبة أول شارع الهرم بجوار داري , الجيزة
مستشفى بهية الشيخ زايد
٤٠ الحي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

PATIENT NAME: SHOROK MOHAMED ABD EL AZIZ SHEHATA **GENDER:** Female **DATE :** 01-Sep-2026 12:47 PM	**PATIENT ID:** 20226033042 **AGE:** 42 y **ORDER:** Z497973,Z497974

FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

INDICATION:

- Mastalgia.
- Positive FH (Mother and younger sister).

TECHNIQUE:

- CC and MLO view.
- Complementary ultrasound.

REPORT:

- Heterogeneously fibroglandular densities (ACR C).

Right breast:

- Right breast UOQ segmental suspicious microcalcifications reaching to the nipple with underlying isodense mass.
- These microcalcifications occupying an area measures about 9.8 x 5 cm (measured at MLO view).

Complementary US shows:

- UOQ 11 o'clock two irregular hypoechoic masses with speculations the nearest to the nipple (about 4 cm away from nipple), (about 0.3cm from overlying skin) Measures about 0.5x0.7cm, the second similar lesion measures about 0.7x0.8cm, both lesions showing internal vascularity on CF application.
- Both lesions are surrounding by altered parenchyma and suspicious microcalcifications reaching the nipple.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.
- Right axillary level I indeterminate LN measures about 1x 0.5cm with diffuse cortical thickness measures 0.3cm.
- Free infra/supraclavicular regions.

Left breast:

- No spiculated mass lesions or grouped microcalcifications.
- This was confirmed by Complementary Ultrasound which showed no solid or cystic mass lesions.

www.Baheya.org
16602
مركز بهية الهرم
4 شارع علوية أول شارع الهرم بجوار داري , الجيزة
مستشفى بهية الشيخ زايد
٤٠ الحي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

PATIENT NAME: SHOROK MOHAMMED NADER ABD EL AZIZ **GENDER:** Female **DATE :** 04-Oct-2026 02:20 PM	**PATIENT ID:** 20226033042 **AGE:** 42 y **ORDER:** 4053848

POST CONTRAST MRI EXAMINATION OF THE BRAIN

MRI TECHNIQUE:

- Sagittal T2WI
- Axial T1, T2 and FLAIR WIs
- Coronal T1WI
- DWI and ADC

* Post Contrast axial, coronal and Sagittal images

MRI FINDINGS:

- Bilateral extra-axial middle cranial fossa cysts, larger at the left side measuring roughly 35 x 24 mm, extending to the Sylvian fissure on the left side. They follow CSF in all MRI sequences with free diffusion. They show mild mass effect on the ipsilateral temporal lobes likely arachnoid cysts.
- Normal size and configuration of the ventricular system with no evidence of hydrocephalus or atrophy.
- Normal size and parenchymal signal intensity pattern of the cerebral hemispheres, cerebellum, and brain stem.
- No parenchymal areas of abnormal enhancement. No intra axial S.O.Ls.
- No areas of diffusion restriction or blood degradation byproducts.
- No shift of the midline structures.
- Intact cranio-cervical junction.

OPINION:

- ***Bilateral cerebral arachnoid cysts as described.***
- ***Normal MRI of the brain with no parenchymal areas of abnormal enhancement.***

Reported By,
Dr. Ali Saber, MSc
Dr. Mahmoud Ibrahim, MD **05-Oct-2026 11:00 AM**

www.Baheya.org
16602
مركز بهية الهرم
4 شارع علوبة أول شارع الهرم بجوار داري , الجيزة
مستشفى بهية الشيخ زايد
٤٠ الحي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

M.R.I
[[DOCTYPE:MRI]]

PATIENT NAME: SHOROK MOHAMED ABD EL AZIZ SHEHATA **GENDER:** Female **DATE :** 29-Sep-2026 01:34 PM	**PATIENT ID:** 20226033042 **AGE:** 42 y **ORDER:** 4049367

WHOLE BODY [18F] FDG PET-CT SCAN

CLINICAL HISTORY:

- 42-year-old female patient, presented with right breast cancer (Invasive micropapillary carcinoma, grade 2).

REASON FOR THE STUDY:

- Initial staging

TECHNIQUE:

- **Radiopharmaceutical**: 4.2 **18F-FDG**, intravenously.
- **Time from 18F-FDG injection to scan:** 60 min
- **PET/CT images** were acquired from the skull through the upper thighs & **CT images** were acquired for the purpose of anatomical localization and attenuation correction. Images were reviewed in the transaxial, coronal, and sagittal planes.
- CT without contrast was performed.
- **Patient's weight:** 79 Kg -**Bl. Gluc. Level:** 96 mg/dL
- **Additional notes:** SUVmax normalized to body weight was used.
  *** Reference hepatic activity (SUVmax): 2.5**

FINDINGS:

Both breasts, and regional lymph nodes:

- **Metabolically active right breast UOQ ill defined parenchymal area of non mass lesion measuring roughly 3.8 x 1.6 cm along its maximal axial dimensions, and eliciting SUVmax~ 6.24, with no definite infiltration of the overlying skin or underlying muscles.**
- No left breast FDG avid lesions.
- Few non FDG avid enlarged right axillary (level I) lymph nodes are noted, reaching 1.4 x 1 cm with no significant metabolic activity.
- Few non FDG avid enlarged left axillary (level I) lymph nodes are noted, reaching 1.1 x 0.7 cm with no significant metabolic activity, likely

www.Baheya.org
16602
مركز بهية الهرم
4 شارع علوية أول شارع الهرم بجوار داري , الجيزة
مستشفى بهية الشيخ زايد
٤ الحي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

proximal appendicular skeleton, likely reactive hyperplasia, for clinical correlation.

CONCLUSION:

Whole body (FDG) PET/CT study showing:

- **Metabolically active right breast UOQ parenchymal non mass lesion coping with pathologically proven malignant lesion.**
- **Low metabolically active left proximal humeral shaft intramedullary lucent lesion showing internal calcific foci, no cortical breaching or endosteal scalloping, likely enchondroma.**
- **Left anterior temporal hypodense area, possibly arachnoid cyst for further MRI assessment if clinically indicated.**
- **Otherwise, no metabolically active lesions identified allover the surveyed body denoting metastatic deposits.**

Reported By,
Dr. Mohamed Hossameldin, MSc
Dr. Salwa Yahya, MD
Prof. Mai Amr, MD **30-Sep-2026 03:01 PM**

www.Baheya.org
16602
مركز بهية الهرم
4 شارع علوية أول شارع الهرم بجوار داري , الجيزة
مستشفى بهية الشيخ زايد
٤٠ الحي الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]